



GUIA PARA PACIENTES

Ombro congelado (capsulite adesiva)

entenda as fases e o que ajuda

Por que o ombro trava, quanto tempo isso costuma durar e o que você pode fazer, sem forçar, em cada fase.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **CAPSULITE**

Para quem é:

Para quem já recebeu de um médico o diagnóstico de capsulite adesiva (ombro congelado), ou está com o ombro doloroso e duro e **aguardando a consulta, sem nenhum dos sinais de alerta da próxima página.**

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem operou o ombro ou teve fratura no braço há pouco tempo: siga a orientação da sua equipe.
- Quem ainda não foi examinado e não sabe a causa da dor. Ombro duro e doloroso tem várias causas (artrose, tendão rompido, calcificação, luxação antiga). Só o exame separa uma da outra [1].

O que você vai precisar:

- Uma mesa firme e uma toalha.
- Um cabo de vassoura ou bastão leve.
- Uma parede livre, fita adesiva e uma fita métrica.
- Este guia e uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Na capsulite, **forçar não "solta" o ombro.** Movimento dentro do limite da dor **sim.** Movimento que deixa a dor mais forte à noite, **não.**

Nem toda dor no ombro é capsulite. Algumas causas são urgentes. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure um pronto-socorro HOJE se:

- A dor no ombro ou no braço vem com **aperto ou peso no peito, falta de ar, suor frio, enjoo ou mal-estar**, principalmente ao esforço. Dor do coração pode aparecer no ombro, no braço, no pescoço e na mandíbula [2].
- Você tem **febre** e o ombro está **quente, inchado ou vermelho**, ou piorou muito depois de uma injeção ou cirurgia recente. Pode ser infecção na articulação [1].
- A dor começou depois de **queda, batida ou acidente**, o ombro está deformado, "saiu do lugar" ou você não consegue mexer o braço. Pode ser fratura ou luxação [1].
- O ombro travou depois de **convulsão ou choque elétrico**. Nessas situações, uma luxação pode passar despercebida (opinião clínica).

Procure avaliação em poucos dias se:

- Você **perdeu de repente a força** para levantar o braço depois de um esforço ou queda [1].
- Você já teve **câncer**, está **perdendo peso sem querer** ou a dor **não alivia com nada** [1].
- Há **várias articulações** inchadas ou doloridas ao mesmo tempo [1].
- A dor **desce do pescoço até a mão**, com formigamento (opinião clínica).

O que acontece no ombro

O ombro é envolvido por uma "bolsa" de tecido, a cápsula articular. Na capsulite, essa cápsula **inflama, engrossa e encolhe**. O resultado é dor e perda de movimento em todas as direções, inclusive quando outra pessoa tenta mover o seu braço [1].

O movimento que mais costuma sumir é **girar o braço para fora** com o cotovelo junto ao corpo. É um dos sinais que o médico procura no exame [1].

A radiografia costuma ser normal. Ela serve para **afastar outras causas**, como artrose ou luxação [1].

Quem tem mais risco

- Pessoas entre **40 e 65 anos**, mais as **mulheres** [3].
- Quem tem **diabetes**: numa análise de vários estudos, cerca de 13 em cada 100 diabéticos tinham capsulite, e o risco foi cerca de 5 vezes maior que em quem não tem diabetes [4]. Nos diabéticos, a resposta ao tratamento costuma ser mais lenta [1].
- Quem tem **doença da tireoide**, principalmente hipotireoidismo [3][5].
- Quem **já teve no outro ombro** [3].

Uma pista importante: como a ligação com o diabetes é forte, os autores sugerem investigar diabetes em quem tem capsulite [4]. Se você nunca mediu a glicose, converse com seu médico.

A descrição clássica divide a capsulite em três fases, que **se sobrepõem** [1]:

- **1. Fase dolorosa ("congelando"):** dor forte, pior à noite, e o movimento vai sumindo. Em geral, de 2 a 9 meses.
- **2. Fase rígida ("congelada"):** a dor diminui, mas o ombro fica duro. Em geral, de 4 a 12 meses.
- **3. Fase de descongelamento:** o movimento volta aos poucos. Em geral, de 12 a 42 meses.

O que a ciência sabe, de verdade

A ideia de que todo mundo passa pelas três fases e **sara sozinho por completo** é mais antiga do que bem provada. Uma revisão de 2017 encontrou só 7 estudos sobre o tema, todos de baixa qualidade. Sem tratamento, houve **alguma melhora, mas não completa**, em 1 a 4 anos. **Não houve prova** de recuperação total espontânea [6].

Num estudo que acompanhou 223 pessoas por cerca de 4 anos e meio [7]:

- 59 em cada 100 estavam com o ombro normal ou quase normal.
- 41 em cada 100 ainda tinham algum sintoma, quase sempre leve.
- 6 em cada 100 tinham sintomas importantes.
- Quem começou com dor mais forte teve evolução pior.

Resumo honesto: a maioria melhora muito, mas pode levar de 1 a 3 anos ou mais, e nem todo mundo volta a 100%.

A fase manda na intensidade

A diretriz de fisioterapia dos Estados Unidos recomenda exercícios de alongamento com **intensidade ajustada ao quanto o ombro está irritado** [3]:

- **Fase dolorosa:** movimentos suaves, curtos, sem buscar ganho de amplitude. O objetivo é **não perder** o que você tem.
- **Fase rígida:** alongamentos um pouco mais longos, sempre progressivos.

Por que não forçar

Num estudo com 77 pessoas, quem fez exercícios **dentro do limite da dor** teve resultado melhor em 2 anos (89 em cada 100 com função normal ou quase) do que quem fez fisioterapia intensiva com alongamento forçado (63 em cada 100) [8]. **Cautela:** os grupos não foram sorteados, então o estudo sugere, mas não prova.

O semáforo da dor (opinião clínica)

- **Verde:** desconforto leve de alongamento que passa em poucos minutos depois de parar. Pode seguir.
- **Amarelo:** dor que dura algumas horas. Diminua a amplitude e as repetições.
- **Vermelho:** dor que piora a noite seguinte ou tira o sono. Volte ao nível anterior e avise seu médico.

Use o braço na vida real

Pentear o cabelo, vestir a roupa, alcançar objetos leves: o que for possível sem dor forte também conta como exercício. Usar tipoia por longos períodos sem indicação médica favorece a rigidez (opinião clínica).

Antes de começar: nenhum exercício específico se mostrou superior a outro na capsulite. Estes são exercícios simples, usados em programas caseiros e no consultório (opinião clínica). Exercícios em casa, junto com o tratamento médico, parecem somar benefício [11].

1 — Pendular

Como fazer: apoie a mão boa numa mesa e incline o tronco para a frente. Deixe o braço dolorido **pendurado e solto**. Balance o **corpo** de leve, para o braço fazer pequenos círculos e vaivém. De 30 a 60 segundos.

Sensação correta: braço pesado, solto, com leve tração no ombro.

Erro comum: girar o braço usando o músculo do ombro. Quem mexe é o corpo.

2 — Deslizamento na mesa (e depois na parede)

Como fazer: sentado ao lado da mesa, mão sobre uma toalha. Deslize a mão para a frente inclinando o tronco, segure 5 segundos e volte. 10 vezes. Quando a dor ceder: de frente para a parede, "caminhe" com os dedos para cima até onde for confortável.

Sensação correta: alongamento leve embaixo do braço.

Erro comum: subir o ombro em direção à orelha ou arquear as costas para "ganhar" altura.

3 — Rotação para fora com bastão

Como fazer: deitado de costas, cotovelos dobrados e colados ao corpo, segure o bastão com as duas mãos. A mão boa empurra o bastão para que a mão do lado doente gire para fora. Segure 5 a 10 segundos. 10 vezes.

Sensação correta: alongamento na frente do ombro.

Erro comum: descolar o cotovelo do corpo. É o movimento mais travado na capsulite [1]: espere ganhos lentos.

Quantas vezes: sessões curtas, 2 a 3 vezes ao dia, respeitando o semáforo da Página 6.

Este guia não indica remédio, dose nem procedimento. Quem decide é o seu médico, com base no seu exame, na fase e na sua saúde.

Infusão de corticoide no ombro

É a aplicação de um anti-inflamatório potente dentro da articulação.

- Revisões Cochrane apontam **benefício nas primeiras semanas**, mas o efeito pode ser pequeno e não se manter [10]. Exercício e terapia manual sozinhos parecem menos eficazes que a infiltração a curto prazo [9].
- Uma análise de 65 estudos (4.097 pessoas) encontrou mais alívio da dor a curto prazo com a infiltração, principalmente quando feita **no primeiro ano** de doença e **junto com exercícios em casa** [11].
- A diretriz americana diz o mesmo: infiltração mais exercício alivia mais em 4 a 6 semanas que exercício sozinho [3].
- Não é para todos. Em quem tem diabetes, por exemplo, a infiltração pode alterar a glicose nos dias seguintes (orientação clínica). Isso entra na decisão.

E quando não melhora?

O maior estudo sobre isso, o UK FROST, sorteou 503 adultos com capsulite persistente entre fisioterapia estruturada (com infiltração), manipulação do ombro sob anestesia e cirurgia por vídeo. **Em 12 meses, nenhum foi claramente superior.** A cirurgia teve mais complicações graves [12].

Cirurgia não é atalho. É uma opção para casos selecionados, decidida caso a caso.

Rotina diária sugerida (opinião clínica)

- **Manhã:** pendular + deslizamento (5 a 10 minutos).
- **Tarde:** rotação com bastão + deslizamento.
- **Noite:** pendular leve. Nada de alongar forte antes de dormir.
- **Sono:** um travesseiro apoiando o braço doente costuma deixar a posição mais confortável.

Como medir a parede

De frente para a parede, sempre no mesmo lugar, descalço e no mesmo horário. "Caminhe" com os dedos do braço doente até onde for confortável. Marque com fita e meça do chão até a ponta do dedo médio.

Essa medida caseira não é um teste científico. Ela serve para você ver a tendência ao longo das semanas.

Rastreador semanal

	Dor à noite (0–10)	Pior dor do dia (0–10)	Altura na parede (cm)	Mão nas costas alcança (nádega / cintura / meio das costas)	Mão na nuca? (S/N)
Semana 1					
Semana 2					
Semana 3					
Semana 4					
Semana 6					
Semana 8					

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. Na capsulite, a melhora é lenta: semanas dizem mais que dias.

1. Forçar na fase dolorosa.

"Tem que doer para soltar" é mito. Alongar com força o ombro irritado tende a piorar a dor, e exercícios dentro do limite da dor parecem levar a resultado melhor [3][8].

2. Parar de mexer o braço de vez.

Proteger não é imobilizar. Movimento suave e uso no dia a dia fazem parte do tratamento [3].

3. Achar que "passa sozinho e volta 100%".

A maioria melhora muito, mas a recuperação total sem tratamento não está provada, e parte das pessoas fica com algum sintoma [6][7]. Vale acompanhar.

4. Ignorar o diabetes e a tireoide.

A capsulite pode ser a primeira pista de um diabetes ainda não descoberto [4]. Doença da tireoide também aumenta o risco [5].

5. Achar que a cirurgia resolve mais rápido.

No maior estudo comparando tratamentos para quem não melhorou, a cirurgia não foi claramente superior em 12 meses e teve mais complicações graves [12].

Procure avaliação médica se:

- O ombro está **doloroso e perdendo movimento há algumas semanas** e você ainda não tem diagnóstico.
- A dor **tira o seu sono** na maioria das noites.
- Você faz os exercícios há **6 a 12 semanas** e o rastreador não mostra melhora.
- Você tem **diabetes ou doença da tireoide**, ou nunca investigou.
- A dor começou também **no outro ombro**.
- **A qualquer momento**: aparecer algum sinal da Página 3.

Os prazos acima são de bom senso clínico, coerentes com a reavaliação após 6 semanas de fisioterapia proposta pela sociedade britânica de ombro [1]. Não são uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

Na consulta, a avaliação é feita **com exame físico**: movimentos que você faz sozinho e movimentos que o médico faz com o seu braço, força e testes dos tendões. A radiografia ajuda a afastar outras causas [1]. Só depois disso se decide o tratamento. Quando o caso pede um especialista em ombro, o encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: [@robertorodriguesmd](https://www.instagram.com/robertorodriguesmd)

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Rangan A, Goodchild L, Gibson J, Brownson P, Thomas M, Rees J, Kulkarni R. **Frozen Shoulder**. (BESS/BOA Patient Care Pathway.) Shoulder Elbow. 2015;7(4):299-307. doi:10.1177/1758573215601779. PMID: 27582992.
2. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, et al. **2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain**. Circulation. 2021;144(22):e368-e454. doi:10.1161/CIR.0000000000001029. PMID: 34709879.
3. Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, Michener LA, et al. **Shoulder pain and mobility deficits: adhesive capsulitis**. Clinical practice guidelines (Orthopaedic Section, American Physical Therapy Association). J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(5):A1-A31. doi:10.2519/jospt.2013.0302. PMID: 23636125.
4. Zreik NH, Malik RA, Charalambous CP. **Adhesive capsulitis of the shoulder and diabetes: a meta-analysis of prevalence**. Muscles Ligaments Tendons J. 2016;6(1):26-34. doi:10.11138/mltj/2016.6.1.026. PMID: 27331029.
5. Chuang SH, Chen YP, Huang SW, Kuo YJ. **Association between adhesive capsulitis and thyroid disease: a meta-analysis**. J Shoulder Elbow Surg. 2023;32(6):1314-1322. doi:10.1016/j.jse.2023.01.033. PMID: 36871608.
6. Wong CK, Levine WN, Deo K, Kesting RS, et al. **Natural history of frozen shoulder: fact or fiction? A systematic review**. Physiotherapy. 2017;103(1):40-47. doi:10.1016/j.physio.2016.05.009. PMID: 27641499.
7. Hand C, Clipsham K, Rees JL, Carr AJ. **Long-term outcome of frozen shoulder**. J Shoulder Elbow Surg. 2008;17(2):231-236. doi:10.1016/j.jse.2007.05.009. PMID: 17993282.
8. Diercks RL, Stevens M. **Gentle thawing of the frozen shoulder: a prospective study of supervised neglect versus intensive physical therapy in seventy-seven patients with frozen shoulder syndrome followed up for two years**. J Shoulder Elbow Surg. 2004;13(5):499-502. doi:10.1016/j.jse.2004.03.002. PMID: 15383804.
9. Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, et al. **Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder)**. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(8):CD011275. doi:10.1002/14651858.CD011275. PMID: 25157702.
10. Buchbinder R, Green S, Youd JM. **Corticosteroid injections for shoulder pain**. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1):CD004016. doi:10.1002/14651858.CD004016. PMID: 12535501.
11. Challoumas D, Biddle M, McLean M, Millar NL. **Comparison of treatments for frozen shoulder: a systematic review and meta-analysis**. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2029581. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.29581. PMID: 33326025.
12. Rangan A, Brealey SD, Keding A, Corbacho B, et al; UK FROST Study Group. **Management of adults with primary frozen shoulder in secondary care (UK FROST): a multicentre, pragmatic, three-arm, superiority randomised clinical trial**. Lancet. 2020;396(10256):977-989. doi:10.1016/S0140-6736(20)31965-6. PMID: 33010843.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

